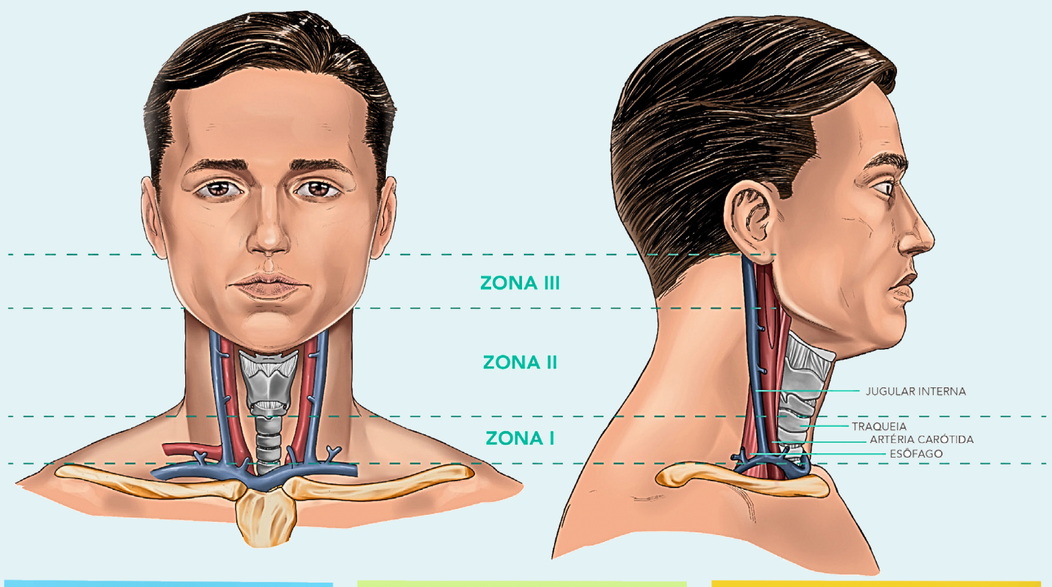
Trauma Cervical Penetrante

Mapa mental referente à aula "**Trauma de Face e Cervical**" de Cirurgia dos cursos Extensivo e Intensivo do Estratégia MED.

- As lesões penetrantes são o mecanismo de trauma mais comum da região cervical;
- É considerado ferimento cervical penetrante quando há ultrapassagem do músculo platisma.

Anatomia

ZONAS CERVICAIS



Zona I: Abaixo da cartilagem cricoide até o esterno e as clavículas. Lesões mais graves e acesso cirúrgico mais difícil

Zona II: Entre a cartilagem cricoide e o ângulo da mandíbula. Local mais comum das lesões e mais acessível cirurgicamente

Zona III: Acima do ângulo da mandíbula até a base do crânio. Difícil acesso cirúrgico - não raro, lesões vasculares são reparadas por meio de radiologia intervencionista

Clínica

Lesões vasculares: hematoma (em expansão ou pulsátil), choque, sangramento ativo, sopros e frêmitos, pulsos periféricos diminuídos ou ausentes, déficit neurológico por lesão vascular

Lesões laringotraqueais: desconforto respiratório, estridor, enfisema subcutâneo, hemoptise, odinofagia e disfonia/rouquidão

Lesões faringoesofágicas: disfagia, saliva com sangue, hematêmese e enfisema subcutâneo. Tem alta morbimortalidade pelo risco de mediastinite

Via Aérea Definitiva

Indicações de via área definitiva imediata:

- Hematoma volumoso no pescoço (deslocamento e obstrução da via aérea)
- Distorção da anatomia cervical (desvio de traqueia)
- Hemoptise franca (sangramento das vias aéreas superiores)
- Enfisema subcutâneo extenso do pescoço
- Sopro ou frêmito
- Estridor
- Disfagia e odinofagia
- Rouquidão

Qual será a modalidade de via aérea definitiva?

- IOT
- Cricotireoidostomia
  - ✓Falha de intubação orotraqueal;
  - ✓Distorção anatômica das vias aéreas superiores (por exemplo, desvio de traqueia causado por hematoma cervical volumoso);
  - ✓Traumatismo facial extenso com sangramento orofaríngeo importante que impossibilita a aspiração adequada e visualização das cordas vocais;
  - ✓Edema de glote.
- Traqueostomia
  - ✓Fratura de laringe: **rouquidão, enfisema subcutâneo e fratura palpável**
  - ✓Crianças < 12 anos

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cervicotomia Exploradora Imediata

1. Instabilidade hemodinâmica
2. Sangramento ativo
3. Hematoma volumoso e/ou pulsátil e/ou em expansão
4. Lesões “óbvias” de via aerodigestiva:
✓Ar borbulhando na ferida
✓Insuficiência respiratória
✓Saída de saliva pelo orifício da lesão
✓ Enfisema subcutâneo ou mediastinal
✓ Disfonia/rouquidão/estridor
✓ Disfagia

CONTROLE DE HEMORRAGIA

- Compressão direta
- Passagem de cateter balonado: medida temporária
- Tratamento cirúrgico

Exames Complementares

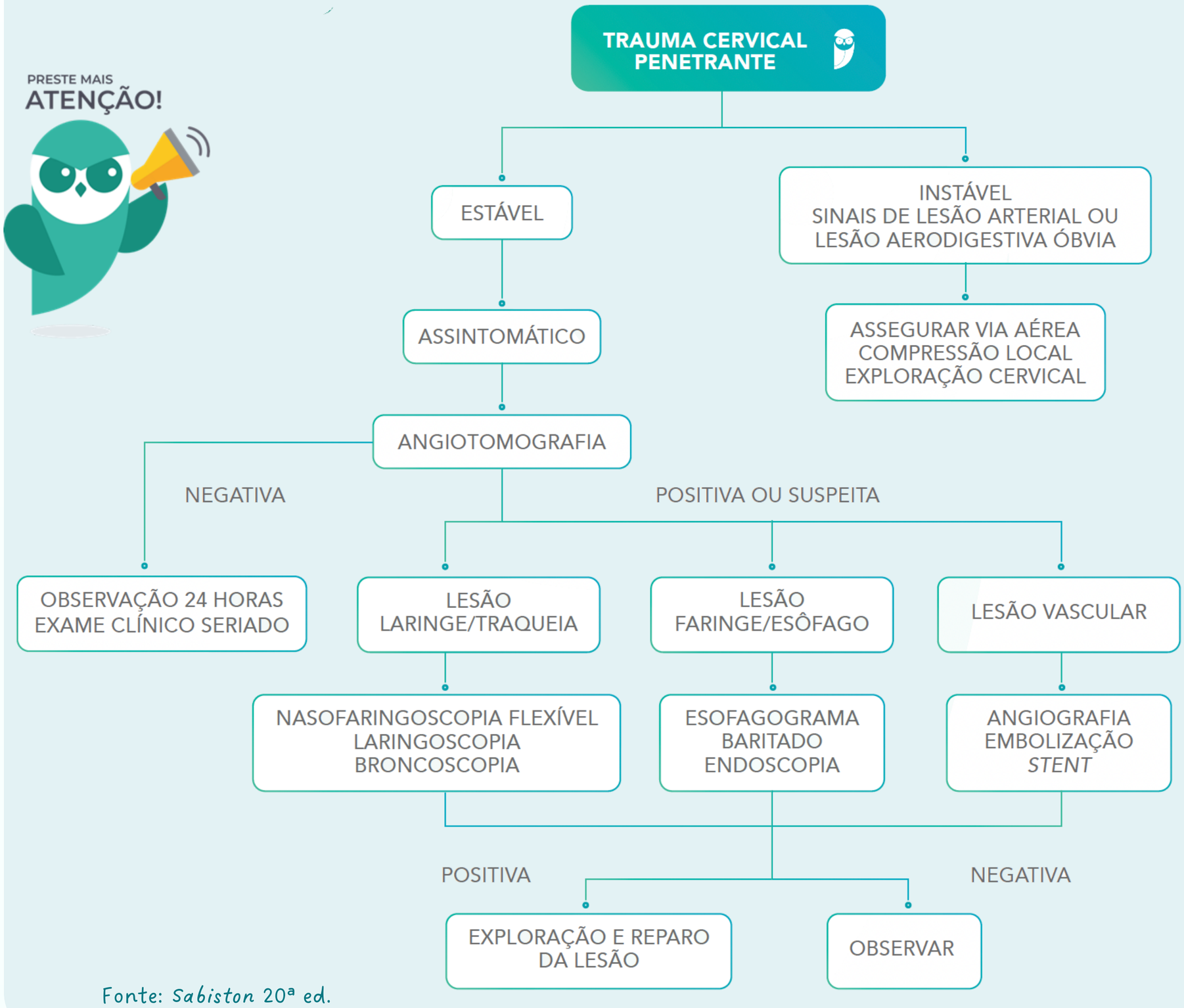
> **Lesão vascular**: Angiotomografia / Arteriografia / USG Doppler

>**Lesão de laringe**: Laringoscopia

> **Lesão de traqueia**: Broncoscopia

> **Lesão de esôfago**: EDA + esofagograma

Fluxograma de atendimento



Fonte: Sabiston 20ª ed.

OBSERVAÇÃO – CONDUTA CIRÚRGICA NA LESÃO ESOFÁGICA:

***Pouco tempo de evolução (< 12 horas) e lesões pequenas**: desbridamento, reparo primário em um ou dois planos e drenagem ampla. Passar SNE sob visão direta.

***Maior tempo de evolução (> 12 horas) e/ou perda tecidual maciça**: esofagostomia (desviar as secreções da orofaringe e prevenir mediastinite) e reconstrução tardia. Associar gastrostomia ou jejunostomia alimentar.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina